Patientkontrollerad sedering (PSS) med Propofol, rutin för endoskopienheten Jönköping

Bakgrund

Propofol är ett intravenöst läkemedel som används för sövning och sedering. Vid patientstyrd sedering med Propofol ger patienten sig själv, med ett knapptryck, små doser tills önskad sederingsnivå uppnås. Målet är att på ett säkert sätt erbjuda komfortsedering utanför operationsavdelningen.

Sedering innebär liksom sövning risker för andnings- och cirkulationspåverkan varför övervakning krävs och beredskapen för komplikationer ska vara hög.

Patienten övervakas av en legitimerad sjuksköterska som har reell klinisk kompetens att tolka och snabbt vidta åtgärd vid avvikande övervakningsparametrar såväl under som efter sedering.

Patientgrupp

- Ålder > 16 år
- ASA 1 och 2 (se bilaga)
- BMI < 40

Kontraindikationer

- Kommunikationssvårigheter (exempelvis tolkbehov och demens).
- Omfattande läkemedelsbehandling för psykiska besvär samt behandling mot ADHD/narkolepsi med t.ex. amfetaminanaloger [4,5,6,7] (Elvanse, Dexatin, Attentin m.fl.), methylphenidate[10] (Concerta, Ritalin) samt modafinil[8,9] (Provigil).
- Gravid > vecka 36.
- Allergi mot Propofol
- Anestesiproblemkort * (uppmärksamhetssignal i Cosmic med anestesiproblem eller allergi mot läkemedel vid anestesi).
- Akalasi
- Känt stort hiatushernia (bråck på magmunnen)

Allergi mot jordnötter eller soja är inte en kontraindikation för att få Propofol[1].

Vid tveksamhet kring lämplighet för PSS, skicka endoskopijournal med hälsodeklaration till endoskopienheten eller ring narkosläkare på telefon 294 01 för bedömning.

* Anestesiproblemkort är något patienten själv fått och har. Det är ett gult litet kort. Har patienten inte kvar det kan man eftersöka det i OP/IVA:s journal Metavision och/eller leta i NPÖ.

Förberedelse

- Muntlig information ges på plats på behandlingsdagen.
- Aktuell hälsodeklaration och checklista gås igenom före behandlingsstart.
- Patienten skall vara fastande 6 timmar preoperativt enligt SFAI:s riktlinjer (se bilaga).
- Alla i teamet ska vid behov kunna larma enligt gängse rutin.
- Alla i teamet ska vara väl insatta i gällande direktiv.
- Endoskopienhetens narkosläkare informeras om dagens PSS-program på morgonen.

Utrustning

- Pulsoximeter
- Blodtrycksmanschett
- Syrgas och grimma
- Rubens blåsa/Andningsballong (testad) inkl. mask nr 3 och 4
- Svalgtuber (olika storlekar)
- Nästuber/näskantareller (stl 26-30).
- Sug (testas före behandlingsstart)

Läkemedel (utöver Propofol)

- Atropin 0,5 mg/ml

Tillvägagångssätt

1. Läkemedel bereds enligt generellt direktiv från operations- och intensivvårdskliniken. Propofol 10 mg/ml dras upp i 20-50 ml spruta av patientansvarig sjuksköterska och monteras i PSS-pumpen. PSS-pumpen skall vara inställd på 0,8 ml/ bolus och max 8 ggr/minut (förinställda värden kontrolleras). Atropin 0,5 mg ska finnas tillgängligt.
2. Uppkoppling till övervakning:
    a. Pulsoximeter
    b. Blodtrycksmanschett.
3. Syrgasgrimma kopplad (0-2 l/minut).
4. PVK företrädesvis vänster arm och inte i samma arm som blodtrycksmanschett.
5. Start av proceduren då patienten uppmanas att trycka upprepade gånger för bolusdos tills målnivå nås. Målnivå är 2-3 enligt Ramsayskalan (se bilaga).

Endast patienten får trycka på knappen.

Endoskopienhetens narkosläkare (tfn 294 01) tillkallas vid behov.

Efter sedering
Patienten ska observeras tills hen är helt vaken och mobiliserad (minst 30 minuter).

Information före hemgång skall innefatta att det inte är tillåtet att köra bil, hantera motorredskap, ta hand om spädbarn samt att underteckna viktiga handlingar samma dag.

Ansvar
All personal som medverkar i processen ”Patientkontrollerad sedering med Propofol” arbetar på eget yrkesansvar och är ålagda att följa givna direktiv från operations- och intensivvårdskliniken.

All personal ansvarar för att upprätthålla sin kompetens avseende luftväg och ska en gång om året genomgå repetitionsutbildning ”Fria luftvägar” som anordnas av operations- och intensivvårdskliniken.

Ny personal som ska arbeta med patientkontrollerad Propofolsedering måste först genomgå utbildning.

Beredning/ordination/administrering av Propofol sker enligt generellt direktiv från operations- och intensivvårdskliniken.

Utarbetat av
Martin Holmer, överläkare och Markus Weis, överläkare, operations- och intensivvårdskliniken Ryhov

Godkänt av
Magnus Trofast, verksamhetschef, operations- och intensivvårdskliniken Ryhov

Jens Christian Larsen, verksamhetschef, kirurgkliniken Ryhov

Bilaga 1 ASA-klassifikation (SFAI, 2015)
Lokalt förtydligande i samband med PSS: Obstruktiv sömnapné som behandlas med CPAP eller apnéskena tillhör ASA-klass 3[2, 3] och utgör därmed en kontraindikation för PSS.

https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/ASA-klassifikation-p%C3%A5-svenska-151101.pdf

Bilaga 2 Preoperativ fasta
Fastetider för vuxna som planeras för elektiv anestesi/sedering:

- Vuxna ska uppmuntras att dricka klar dryck fram till två timmar före anestesistart. Med klar dryck menas t.ex. vatten, saft, fruktdryck utan kolsyra, juice utan fruktkött, kaffe, te och isglass.[2,3]
- Kolhydratberikade klara drycker kan intas fram till 2 timmar före anestesistart.[2,4]

- Fast föda och övrig dryck kan intas fram till sex timmar före anestesistart. Längre fastetid kan behövas om patienten ätit fet mat eller kött.[2,3]
- Preoperativa läkemedel kan administreras oralt fram till 1 timme före anestesistart med en mindre mängd klar dryck.
- Anestesi/sedering ska inte skjutas upp för att en patient tuggat tuggummi.[2,4]

Hela preoperativ fasta dokumentet (SFAI), Nationell riktlinje Fasta vid anestesi (sfai.se)

Bilaga 3 Sederingsskala enligt Ramsay

Sederingsskala enligt Ramsay (Vårdhandboken)

Referenser

1. Propofol and food allergy N. J. N. Harper. British Journal of Anaesthesia 116 (1): 11–13 (2016)
2. ASA physical status classification of obstructive sleep apnoea disease. J Clin Anesth. 2018 Feb. 44:19-20. [QxMD MEDLINE Link].
3. ASA Physical Status Classification, Updated: Feb 29, 2024. Author: Muhammad Fayyaz Ahmed, MBBS; Chief Editor: Buck Christensen; Medscape
4. Illicit Drug Use and Endoscopy: When Do We Say No? John P. Gallagher; Patrick A. Twohig; Agnes Crnic; Fedja A. Rochling2. Digestive Diseases and Sciences (2022) 67:5371–5381.
5. General Anesthesia and Chronic Amphetamine Use: Should the Drug Be Stopped Preoperatively? Fischer, Stephen P. MD; Schmiesing, Clifford A. MD; Guta, Cosmin G. MD; Brock-Utne, John G. MD, PhD. Anesthesia & Analgesia 103(1):p 203-206, July 2006.
6. Hemodynamic Effects of Methamphetamine and General Anesthesia. Keyvan M. Safdari; Curtis Converse; Fanglong Dong; Nickolas Alan MacDougall; Kevin Hyer; Alec Runyon; Haley Ahlering; and Mark E. Comunale. Anesthesiol Res Pract. 2022; 2022: 7542311.
7. Hemodynamic profile and behavioral characteristics during induction of anesthesia in pediatric patients with attention deficit hyperactivity disorder. Richard S. Cartabuke, Joseph D. Tobias, Julie Rice, Dmitry Tumin. Pediatric Anesthesia Volume27, Issue4 April 2017, Pages 417-424 08 February 2017
8. Resistance to Propofol Induction in a Patient Taking Modafinil: A Case Report July 2017A & A Case Reports 9(11):1
9. Total Intravenous Anesthesia for Neurosurgical Procedures in Narcoleptic Patients: Two Case Reports. Sara Pedrosa,1,* Nuno Lareiro and Pedro Amorim. Anesth Pain Med. 2017 June; 7(3):e45586.
10. Case report: Unexpected interaction of methylphenidate(Ritalin) with anaesthetic agents. Douglas G. Ririe, Kirsten L. Ririe, Navil F. Sethna, and Lizanne Fox. Paediatric Anaesthesia 1997 7: 69–72